

Digital årskontrol: Kan patienter med velbehandlet type 2-diabetes følges digitalt uden at behandlingskvaliteten forringes?

I samarbejde med udvalgte almen praksis i Region Midtjylland vil Steno Diabetes Center Aarhus undersøge, om årskontrol for personer med velbehandlet type 2-diabetes, hvert andet år kan gennemføres digitalt, uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet.

Baggrund

Antallet af personer med type 2-diabetes (T2D) i Danmark er stigende og skønnes at nå 420.000 i 2030. Flere yngre får T2D og andelen af velhandlede type-2-diabetikere er stigende. Cirka 38 % af T2D populationen i Danmark har ingen kardiovaskulær sygdom og HbA1c<48 og LDL<2,5 mmol/mol [1].

Et studie fra 2024 som fulgte 1938 personer med T2D i alle aldre, viste, at der blandt 44% af deltagerne ikke blev iværksat nogle handlinger i forbindelse med deres årlige diabeteskontrol (dvs. ingen ændring i medicin, ingen henvisninger, ingen samtale om livsstil etc.) [2].

Samtidig er de nuværende retningslinjer for kontrolhyppigheden af velhandlede personer med T2D ikke baseret på evidens, men i høj grad på faglig konsensus [3] og tradition og varierer betydeligt imellem almen praksis i Danmark.

Sundhedsreformen tilsiger, at almen praksis skal overtage kontrollen af flere kronikere, men også at alle patienter i fremtiden skal tilbydes en digital løsning, når det vurderes fagligt forsvarligt, og patienten ønsker det.

Hvis AP skal kunne løfte denne opgave, er det nødvendigt at gentænke og undersøge alternative måder, hvorpå almen praksis ser de mest velhandlede kronikere på.

På den baggrund vil vi undersøge, om hver anden årskontrol hos velregulerede voksne med T2D, kan erstattes af en digital årskontrol uden at gå på kompromis med behandlingskvaliteten. Hvorvidt en person med T2D er velreguleret vurderes ud fra et sæt foruddefinerede indikatorer.

Forsøget vil løbe over to år og blive evalueret på, om deltagerne i det digitale forløb klarer sig lige så godt vedrørende HbA1c, som personer med T2D, der følger standard årskontrol. Samtidig vil vi følge og evaluere øvrige diabetesrelevante værdier, herunder blodtryk, kolesterol, eGFR og UACR, forbruget af konsultationer af alle typer samt antallet af HbA1c-målinger i forsøgsperioden. Gennem kvalitative interviews med deltagerne vil vi undersøge, hvordan en omlægning til digital årskontrol påvirker deltageres diabetesrelaterede livskvalitet. Desuden vil der blive gennemført kvalitative interviews af behandlere.

Vi håber med forsøget at kunne opnå viden om, hvorvidt der hos personer med velbehandlet type 2-diabetes, kan opnås samme parakliniske behandlingskvalitet ved at omlægge hver anden årskontrol til en digital årskontrol. Desuden håber vi at opnå viden

om, hvordan patienter og behandlere oplever denne ændring. Viden, som forhåbentligt ville kunne overføres til andre grupper af kronikere.

Hvem kan deltage:

Alle almen praksis i Region Midt inviteres til at deltage.

Deltagerne identificeres via patientlisten i Forløbsplansoverblikket.

For at deltage skal følgende parakliniske inklusionskriterier være opfyldt:

Type 2-diabetes og følges i almen praksis.

- eGFR >59 ml/min/1.73 m²
- HbA1c:
 - <48 mmol/mol, eller
 - 48–53 mmol/mol hvis patientens HbA1c mål er <53 mmol/mol
- Urin albumin/~~to~~-kreatinin ratio (UACR):
 - <30 mg/g, or
 - 30–300 mg/g og i igangværende behandling med with organ-beskyttende medicin: SGLT-2i eller GLP-1agonist og RAS-blokade med ACE-I eller ARB.
- LDL <2.6 mmol/L

Det er desuden en forudsætning for deltagelse, at personen kan læse og forstå dansk og modtage og sende e-mails i lægesystemet/"Min Læge"-appen. Gravide kan ikke deltage.

Personer, som opfylder kriterierne, og hvor den ansvarlige sundhedsperson finder det medicinsk forsvarligt, at personen ses digitalt, sendes først en kort informationsbesked ([besked 1, bilag 3](#)) i lægesystemets beskedmodul via Min Læge-appen. I beskeden oplyses kort om forsøget og om, at hvis potentielle deltager ønsker yderligere information om forsøget, bedes de kontakte klinikken for at aftale tidspunkt for mundtlig deltagerinformation.

Når der aftales tidspunkt for mundtlig information, er det vigtigt at almen praksis tager hensyn til at dette skal foregå på et tidspunkt, hvor både almen praksis og den potentielle deltager har tilstrækkelig tid og ro til at dette kan gennemføres uden forstyrrelser og med tid til gennemgang af informationsmaterialet og besvarelse af eventuelle spørgsmål.

På det aftalte tidspunkt ringes den potentielle deltager op, og gives mundtlig information om forsøget (se bilag herom). Efter den mundtlige information er givet tilsendes den potentielle deltager en ny besked ([besked 2, bilag 4](#)), som indeholder link til yderligere skriftlig information om forsøget ([bilag 5](#)) og et link til samtykke til deltagelse ([bilag 6](#)). Den potentielle deltager kan på ethvert tidspunkt frabede sig yderligere information om forsøget.

Den digitale årskontrol

Når deltagerne har givet samtykke til deltagelse i forsøget, betyder det, at deres kommende årskontrol skal foregå digitalt. Ved digital årskontrol forstås, at deltageren som vanligt møder til blod- og urinprøve, men selv måler blodtryk og eventuelt vægt og indsender KRAM-oplysninger, samt besvarer spørgeskema, som screener for symptomer på senkomplikationer og problemer med medicin. Når alle svar foreligger, evalueres prøvesvarene af behandleren og sammenholdes med de individuelle mål i Forløbsplanen, hvorefter deltageren tilsendes mailsvar.

Hvis der findes forhold, som kræver behandlingstiltag, er det op til den ansvarlige sundhedsperson at vurdere, om dette kan gøres over mail eller telefon eller kræver, at deltageren bestiller en tid.

I bedste fald, vil der kunne gives besked til deltageren om, at denne skal forsætte sin behandling uændret, og huske at bestille tid til en almindelig årskontrol efter yderligere et år. Der vil blive udviklet en standardfrase til brug ved "normale prøvesvar".

Almen praksis' rolle i udvælgelse, samtykke og dataindsamling

Almen praksis har følgende roller:

- Udvalge potentielle deltagere, som opfylder de parakliniske kriterier ud fra patientlisten i Forløbsoverblikket.
- Evaluere, om der er forhold, som gør den potentielle deltager uegnet til en digital årskontrol.
- Sendte invitationsbesked og give mundtlig information til potentielle deltagere.
- Lave en mindre audit på deltagere. Ved audit oplyses diabetes debutår, senest registrerede rygestatus, vægt og blodtryk ved indrulning, på tidspunktet for deres digitale årskontrol og ved den efterfølgende standard årskontrol.
- Desuden skal almen praksis udfylde et kort skema vedrørende de personer, som opfylder de kvantitative inklusionskriterierne, men som af behandleren vurderes uegnede til digital årskontrol (bilag X). Disse data videregives til projektet i anonymiseret form med fortløbende nummerering og uden angivelse af CPR-numre men hvor det b behandleren blev vurderet uegnet til digital årskontrol (bilag x).

Stenos rolle i samtykke og dataindsamling.

Steno Diabetes Center har følgende roller:

- Samtykke gives til og opbevares af Steno Diabetes Center Aarhus.
- Oplysning om samtykke fra deltagere videregives til almen praksis i E-Boks.

Digital årskontrol. Kan patienter med velreguleret type 2-diabetes følges digitalt uden at kvaliteten af behandlingen forringes?

Honorering

Praksis vil blive honoreret for tidsforbruget til udvælgelse af deltagere, information og samtykke, samt udfyldelse af audit. Praksis, som efterfølgende deltager i kvalitative interviews (frivilligt), vil modtage særskilt honorering herfor.

Tilmeld jeres klinik her: indsæt link

Tidsplan

Rekruttering af deltagere starter september 2026.

Ved spørgsmål er I altid velkomne til at kontakte os.

Kirsten Christensen,
Overlæge, speciallæge i almen medicin
KICHIS@rm.dk
Tlf. +45 2992 5648

Anne Wermuth,
Udvildingskonsulent
annwer@rm.dk
Tlf. +45 2452 9824

Kommenterede [KC1]: Skal præciseres

Kilder.

¹ Diabetestest.nu.

² "Mapping of contact and treatment patterns in patients with type 2 diabetes in general practice." Response report 26 practices in Region of Southern Denmark 2025. A corporate between SDU, APO and Steno Diabetes Center Odense.

³ Xu et al.,2024: Optimizing the frequency of physician encounters in follow - up care for patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review, BMC Primary Care